

두경부 및 피부 · 피부과(한형진) 강의록 정리 + 족보 개념

대상: ① 표피 및 부속기의 모반과 종양 ② 색소 이상증 & 피부노화 ③ 구진비늘질환 · 족보 기준: 2019(17학번 복원)·2021·2022·2023·2025(실제 시험지 포함)

범례

초록 형광펜 = 족보에 출제된 개념

기출 선지

○ 옳은 선지 / ✕ 틀린 선지 (선지만 수록, 문제 전문 제외)

'25 '23 '22 '21 '19 = 출제 연도

족보 추가

= 강의록엔 없으나 족보에 나온 개념

족보 출제 사진

= 강의록 사진이 족보/시험에 그대로 출제됨

출제 주제	연도	핵심 한 줄
건선 일반(역학·악화요인)	'25 '23 '22 '21	초발 10~30대, 가족력 한국 25%, 유병률 한국 1%/미국 2%, 외상 등으로 악화
건선성 관절염 PsA	'25 '23 '22 '21	30~40대(peak 35-40), 성별차 없음, 건선의 6-42%
건선 치료	'25 '23 '22 '21 '19	NBUVB 多, vit D3·steroid=1차 외용, retinoid·MTX 등은 전신
UV 작용/급성·만성 반응	'25 '23 '22 '21	UVA=melanogenic·광노화, UVB=유리창 차단·직접 DNA 손상
백반증	'25 '22 '21 '19	성별차 無, 비유전질환, 세포성+체액성 자가면역, segmental/non-segmental/focal
암전구증	'25 '23 '22 '21	IP(색소실조증)만 전구암증 아님
SCC 재발·전이 고위험	'25 '22 '21	입술·귀, ≥2cm, 침윤 ≥4mm, 재발 병변, 면역억제
표피 vs 진피 melanocytic lesion	'25 '23 '22 '21	진피 = Mongolian spot(Ota-Ito 등)
BCC / Mohs, 악성흑색종, 편평태선, 장미색잔비늘증	'19	PTCH, 재발=Mohs / 백인·거대모반 / Wickham striae / herald patch
광선입술염	'25 '23 '22	피부암 주의 입술염 (강의록 외)

A. 표피 및 부속기의 모반과 종양

피부 종양의 분류 (기원별)

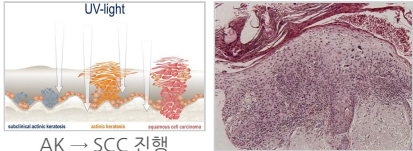
Keratinocytic(BCC, SCC, Bowen, Merkel) · Melanocytic(악성흑색종) · Adnexal · Lympho-hematologic(mycosis fungoides 등) · Neural/Soft tissue · Uncertain · Inherited syndromes(Gorlin, Muir-Torre, XP).

Type of tumor relating to origin	Representative tumors
Keratinocytic·Epidermal (Non-melanoma)	Basal cell carcinoma Squamous cell carcinoma Squamous cell carcinoma in situ (Bowen disease) Merkel cell carcinoma
Melanocytic	Malignant melanoma
Adnexal	Malignant tumours with eccrine and apocrine differentiation Malignant tumours with follicular differentiation Sebaceous carcinoma
Lympho-hematologic	Mycosis fungoides CD30+ T-cell lymphoproliferative disorders Skin T-cell leukaemia/lymphomas (primary or secondary) Skin B-cell lymphomas (primary or secondary) T-lymphoblastic and B-lymphoblastic leukaemia Blastic plasmacytoid dendritic cell neoplasm Skin determination in myeloid leukaemia Malignant peripheral nerve sheath tumour
Neural	
Soft tissue	Liposarcoma Fibroblastic, myofibroblastic and fibrohistiocytic malignant tumour Leiomyosarcoma Skin angiosarcoma Kaposi sarcoma
Uncertain differentiation	Pleomorphic dermal sarcoma Epithelioid sarcoma Myxo-fibrosarcoma Dermal clear cell sarcoma Ewing sarcoma
Inherited syndromes	Familial melanoma Gorlin syndrome (Naevoid basal cell carcinoma syndrome) Skin cancers on Xeroderma pigmentosum Muir-Torre syndrome

피부 종양 분류표

1. 광선각화증 (Actinic keratosis)

- 정의 만성 일광노출 부위의 각화성 종양, 편평세포암으로 이행 가능한 **암전구증**. 가장 흔한 암전구증
- 원인 과다 일광노출·하얀 피부 → **p53 돌연변이**
- 증상 홍~회색 1-10mm 각화성 구진, 단단히 부착된 인설 · **DDx DLE**, 지루각화증, Bowen, SCC
- 치료 전기소작, 냉동, 소파, CO₂ laser, 5-FU 국소 · **예후** 다발성이면 ≈ 10%가 10년 내 SCC
- 암전구증(precancerous)**: 광선각화증, 비소각화증, **백판증(leukoplakia)**, 피각, 선천성 거대색소성모반, 만성방사선피부염, **색소성건피증(XP)**, **Bowen병**, **Queyrat 홍색비후증**



AK → SCC 진행

AK 조직

기출 선지

'25 '23 '22 '21

암전구증으로 옳지 않은 것

✕ 광선각화증 / 백판증 / (Queyrat) 홍색비후증 / 색소성건피증 / Bowen병 → 모두 암전구증이므로 오답선지

○ 색소감소증 IP (incontinentia pigmenti, 색소실조증) ← 매년 정답

'19

악성흑색종 원인 선지

✕ p53 mutation이 원인 (→ p53은 광선각화증의 원인)

족보 추가

IP: 유전성 색소질환으로 암전구증이 아님(강의록엔 없음). 광선입술염(actinic cheilitis): 피부(편평세포)암 유발을 주의해야 하는 입술염 '25 '23 '22 — 오답선지: 구석입술염, 접촉입술염, 벗음입술염, 육아종입술염(→Crohn/샤르코이드증 가능 '25). 강의록 연결고리: 아랫입술 SCC 전이 13%.

2. Bowen병 · Queyrat 홍색비후증

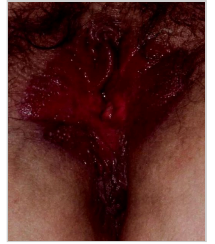
- 표피 내에 국한된 편평세포암(SCC in situ). 원인: 노출부위 만성 일광노출 / 비노출부위 비소중독·방사선·HPV16(33-64%)
- 경계 뚜렷한 홍반성 원형·부정형 판(수 mm~수 cm), 인설·가피·DDx Paget, 악성흑색종, BCC, 건선, 화폐상습진, 체부백선, DLE
- 치료 단순절제, Mohs, 전기소작, 냉동, CO₂, 방사선, 광역동·예후 약 5% SCC 이행, 장기적으로 약 42%에서 피부·점막 전암 또는 암 발생
- Queyrat 홍색비후증: 음경 귀두·포피에 생긴 Bowen병. 악성화 10-33%로 더 침습적, 점막하층 침범 시 ≈20% 국소 림프절 전이

3. Paget병

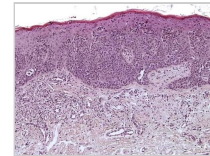
- 유방 Paget**: 표피내 Paget 세포, 유두·유륜 주위 습진성 병변, **유방암 동반**(유선관 선암이 표피로 전이). 편측, 경계 명확·진물 나는 인설성 홍반·미란·가피·얇은 궤양. DDx 신경피부염, 아토피, 화폐상습진, 유두상선종, 유두유륜각화증. 치료 유방절제술
- 유방외 Paget(EMPD)**: 일차=아포크린샘으로 분화할 다기능 줄기세포의 악성화 / 이차=기저 암(내부 장기암)에 의한, **항문주위** 발생이 외음부보다 내부 장기암 동반 확률 높음. 호발 항문·성기·서혜부·액와. 치료 외과적 절제(특히 Mohs)



유방 Paget병



외음부 EMPD



EMPD 조직

4. 기저세포암 (Basal cell carcinoma)

- 인간에서 **가장 흔한 악성종양**(한국인 포함 '19). 자외선 노출 부위, 천천히 커지고 **전이율 극히 낮음**(0.0028-0.55%)
- 원인** 자외선(장기 직업적 노출보다 간헐적·짧은 노출이 위험), 표피 DNA 손상, 외상·반흔, 방사선. 손·발바닥·입술 홍순에는 없음 → 털집(모낭) 유래? **PTCH 조절 유전자 변이**
- DDx SCC, 각화극세포종, AK, 피지선 과형성·치료 외과적 절제 **특히 Mohs 미세도식수술**, 냉동, 방사선, CO₂·완치율 높음

기출 선지 '19 BCC 설명

- ✗ 멜라닌세포 유래 악성종양 (→ 기저세포 유래)
- ✗ 재발 시 광역동 절제 (→ Mohs)
- ✗ p53 변이로 발생 (→ PTCH)
- ✗ 전이율이 높아 예후가 나쁨
- 백인뿐 아니라 한국인에게도 가장 흔한 악성종양 중 하나

족보 추가 Mohs 적응증 = 이전 수술 후 **재발한 경우** '19 (오답선지: 모낭주변 침윤, 뿔, 1cm 크기, 노인, 비공격적 조직형).

5. 편평세포암 (Squamous cell carcinoma)

- 표피 각질형성세포 유래, **림프절 전이 잘 됨**. 원인 UVB, 열상, 화학물질(그을음·광유·타르·비소), 방사선, HPV 5·16, 면역억제, 유전피부질환(백색증, 색소건피증)
- 결절·판상·우체상·궤양, 촉진 시 경결병소 범위를 넘어 침범·DDx AK, 각화극세포종, 가성암종성 과형성
- 전이 6-8%: 일광손상 피부 5%, **아랫입술 13%**, 흉터 40%·전이된 SCC 5년 생존율 34.4%
- 치료 외과적 절제(Mohs), 전기소작, 소파, 방사선, 냉동
- 재발·전이 고위험**: ① 입술·귀 ② 크기 ≥2cm ③ 침윤 깊이 ≥4mm / 뼈·근육·신경 침범 ④ 불완전 분화·방추세포형·중양주위 림프구 소실 ⑤ 발생요인 흉터·만성궤양·만성골수염·자외선조사 ⑥ **재발 병변** ⑦ 면역억제 환자

기출 선지 '25 '22 '21 고위험 인자

- **재발 병변** '22 '21
- **3cm 크기** '25
- ✗ 다리에 발생 / 크기 1cm / 침윤 깊이 2mm '25 '22 '21
- ✗ 몸통에 발생·높은 분화도(well-differentiated)·AK로부터 발생 '25

6. 악성흑색종 (Malignant melanoma)

- WHO 분류: Superficial spreading, Nodular, Lentigo maligna, Acral lentiginous (기타: desmoplastic, blue nevus 유래, giant congenital nevus 유래, 소아, naevoid)

기출 선지 '19 악성흑색종 설명

- 백인이 유색인종보다 발생위험이 높다
- ✗ 2cm 이하 작은 선천성 모반도 흑색종을 유발 (→ 거대 >20cm가 위험)
- ✗ p53 mutation이 원인
- ✗ 장기적·지속적 자외선 노출이 원인 (→ 단기·강한 노출)
- ✗ 점의 수가 많은 것은 위험인자가 아님

족보 추가 위험인자: 백인, 점이 많음, 거대 선천성 모반(>20cm), BRAF-c-kit 변이, 단기 강한 UV.

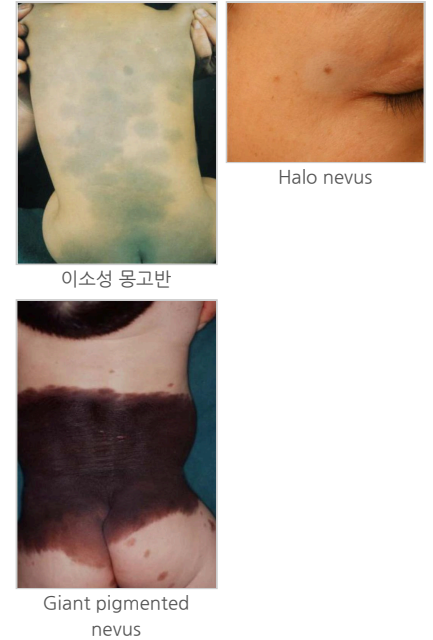


7. 모반 (Nevus)

- 정의 melanocyte 유래 모반세포로 이루어진 종양, hamartoma(보통 출생 시 존재, 성숙 또는 거의 성숙한 구조)
- Epidermal melanocytic lesion: Freckle, Lentigo, Nevus spilus, Becker's nevus, Café-au-lait macule
- Dermal melanocytic lesion: Ota nevus, Mongolian spot, Ito nevus, 후천성 양측성 Ota-like macules, dermal melanocytic hamartoma
- Halo nevus: 탈색소 띠로 둘러싸인 색소모반
- 선천성 모반 (1) Giant pigmented nevus: 털 많은 암색 큰 반 + 위성병변, dermatome(체간) 분포, >20cm, 흑색종 발생 6-12%, 소아 흑색종의 ≈40%, 치료 전절제. (2) Small(<1.5cm)·Medium(1.5-20cm)

기출 선지 '25 '23 '22 '21 진피 melanocytic lesion / 표피 유래가 아닌 것

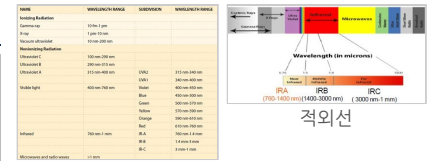
- Mongolian spot (몽고반점) ← 정답
- ✗ lentigo, nevus spilus, Becker's nevus, Café-au-lait macule, freckle (모두 표피)



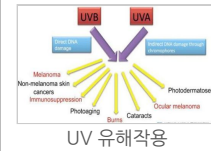
B. 색소 이상증 & 피부노화

1. 자외선 · 적외선

	파장	특징
UVA	320-400nm (UVAII 320-340, UVAI 340-400)	melanogenic action · 홍반 유발 매우 약함 · 광노화에 큰 역할 (지표 햇빛에 약 10배 많음, 연중·종일·하린 날도, 진피 깊이 침투) · 독성은 간접기전 (ROS; porphyrin·riboflavin·quinone 등 광감작제)
UVB	290-320nm	유리창에 차단 · sunburn·suntanning·광발암의 주원인 · 직접 DNA 손상 (CPD: C-C-T-C dimer 가장 mutagenic; 6-4PP는 CPD보다 복구 효율 좋음) · 염증, 면역억제, PGE ₂ , polyamine↑, 혈관신생
UVC	200-290nm	정상 피부 홍반 매우 효율적, 살균, 오존층에 차단되어 지표 도달 X
IR	760nm-1mm (IRA 760-1400 / IRB / IRC)	피부 온도 상승. 최근 IRA는 표피~진피·지방층까지 침투해 손상 가능



전자기파 분류



UV 유해작용

- **MED**: 24시간 후 겨우 인지되는 홍반을 만드는 최소량. UVB 양은 UVA의 1/1000(필요량), **UVB 광자가 UVA보다 약 1000배 더 energetic**. 동양인 MED: UVA 50-70 J/cm², UVB 50-70 mJ/cm²
- 유익 mood↑: 각질세포 UV → POMC promoter 자극 → β-endorphin
- 유해 UVB(직접 DNA 손상) · UVA(발색단 통한 간접 손상) → 흑색종, 비흑색종 피부암, 면역억제, 광노화, 화상, 백내장, 안구흑색종, 광피부염
- **피부 반응 급성**: 홍반(sunburn), 색소침착(tanning) / **만성**: 피부 비후, 광노화, 돌연변이·피부암 / 면역 조절

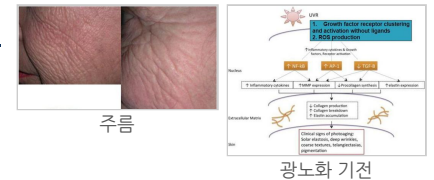
기출 선지 '25 '23 '22 '21

- UVA는 melanogenic action을 한다
- ✗ UVA는 광노화에 영향 없다
- ✗ UVB는 유리창으로 차단할 수 없다 (→ 차단됨)
- ✗ UVB는 DNA를 손상하지 않는다
- ✗ UVA가 UVB의 1/1000이고 광자 에너지 1000배 (→ UVB 쪽이 뒤바뀜)
- ✗ UVB는 melanogenic '23 · UV는 면역에 작용 X / 면역조절 이상과 무관 '25 '23
- UV 급성반응 = 홍반, tanning '25* '23 (*2025 시험지 괄호가 chronic으로 오기된 듯, 강의록 기준 급성)
- ✗ sunburn은 만성 반응 '21 · 피부 두께 증가는 급성 반응 '25 '21 · 광노화는 내인성 노화 '25 '21 · UVA는 각질세포 독성 없음 '25
- 자외선은 direct·indirect DNA damage 모두에 관여 '21

족보 추가 UVA는 유리창을 투과 → 트럭운전사의 광노화(족보 해설). 강의록은 "UVB는 유리창에 차단"만 명시.

2. 피부노화

- **내인성(intrinsic, climacteric)**: 시간 경과에 따른 불가피한 생리적 감퇴 — 건조(거칠음), 주름, 이완, 신생물, 탄력 감소, 상처 회복 지연
- **외인성(extrinsic)**: **UV(가장 중요)**, 바람, 열, 흡연. **광노화** = 만성 일광노출 변화가 내인성 노화 위에 중첩
- **광노화 기전**: UVR → 성장인자 수용체 군집화 + ROS → NF-κB↑·AP-1↑·TGF-β↓ → 염증 cytokine↑, MMP↑, procollagen 합성↓, elastin 발현↑ → collagen 생성↓·분해↑, elastin 축적 → solar elastosis, 깊은 주름, 거친 결, 모세혈관확장, 색소침착
- 활성산소(ROS)가 내인·외인 노화 모두에 큰 역할 → **항산화물질**이 예방에 중요

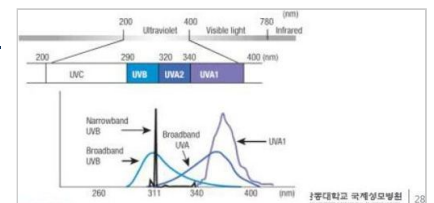


주름

광노화 기전

3. 광치료 (Phototherapy)

- 치료에 도움이 되는 파장의 UV를 선택적으로 조사. **적응증** 건선, 백반증, 아토피피부염, CTCL(mycosis fungoides), 광과민 피부병, 색소성 두드러기
- **종류** 광대역 UVB(290-320), PUVA, **NBUVB(311nm)**, UVA1(고/중용량), 엑시머레이저(308nm; 표적 광치료)
- **NBUVB vs PUVA**: 호전 빠름, 관해 길다, 홍반 적음, 저렴, 광감작제 불필요, 임신·소아 사용 가능, 치료 후 눈 보호 불필요, 발암성 낮음, 피부침윤 T세포 제거 효과는 비슷 · **vs 광대역 UVB**: 더 깊은 침투, 진피 T세포 apoptosis 유도 효율↑, 홍반 적음



광치료 파장

4. 백반증 (Vitiligo)

- **표피 melanocyte** 소실이 병리학적 hallmark. 유병률 0.1-2%, 소아~젊은 성인(10-30세), **성별 차이 없음**. **유전질환은 아니나** 유전소인(약 20%에서 일등친 백반증)
- **임상형: Segmental / Non-segmental / Focal**
 - Segmental: 초기 발병(주로 소아), 빠른 진행 후 안정, dermatomal, 모발 초기 침범 (leukotrichia)
 - Non-segmental: 평생 지속, 예측 불가능한 확산, **Koebner 현상**, 모발은 후기 침범 (acrofacial 등)
- **병인** 유전요인 + **oxidative stress** → 자가면역. **세포성·체액성 자가면역 모두**, keratinocyte apoptosis↑, melanocytorrhagy, 산화스트레스(세포막 변화), autocytotoxicity
- 동반 자가면역질환: 갑상선질환, DM, 부신기능부전, 경피증, SLE, 원형탈모, 중증근무력증, 악성 빈혈. 재색소 치료(스테로이드·calcineurin inhibitor·UV)의 면역억제 효과가 자가면역 가설을 뒷받침
- **광치료 기전** 면역(photoimmunosuppression) + 멜라닌세포: 모낭 outer root sheath의 비활성 melanocyte가 활성화·증식·이동, keratinocyte의 mitogen 방출 자극

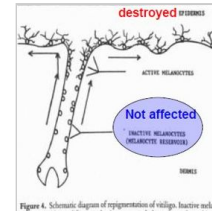


Non-segmental acrofacial



Segmental type

백반증 병변



광치료 재색소 기전

기출 선지 '25 '22 '21

- clinical type으로 segmental, non-segmental, focal type이 있다

✕ 여자가 남자보다 많다 · 멘델 유전법칙을 따르는 유전질환 · 자가면역과 무관

✖ cellular autoimmunity만 중요, humoral은 관여 X (→ 둘 다 중요) · oxidative stress는 관여 X '25

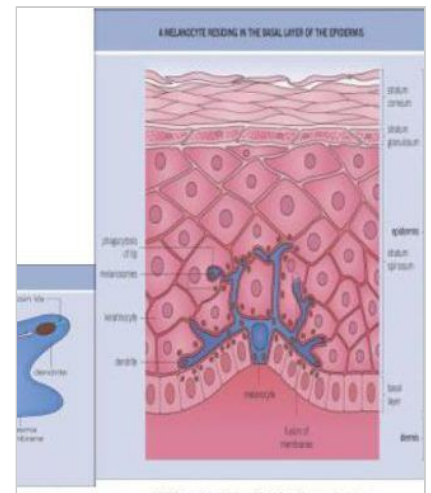
'19 비분절성 백반증

○ 동통.압통 등이 있었던 부위에 잘 생긴다 (= Koebner)

✖ **어릴 때 주로 / 빠르게 나타났다 빠르게 안정** (→ segmental) · 다른 자가면역 질환 동반 안 함 · 자가이식이 효과 좋음

5. 과다색소침착 · 기미

- Melanocyte: neural crest 기원, dendrite, 표피 기저층, MC : KC = 1:10, epidermal melanin unit
- 과다색소침착 목록: Melasma(기미), Peutz-Jeghers, PUVA lentigines(흑색점), Riehl melanosis(흑색증), Dyschromatosis universalis hereditaria(유전전신색소이상증), Dohi acromelanosis(말단흑색증), Reticulate acropigmentation of Kitamura
- **Melasma(Chloasma)**: 그리스어 khloasma=greenness. 햇빛 노출 부위의 불규칙한 연갈~회갈 색 반. 깊이별 epidermal / dermal·mixed(melanophage). 임상형 centrofacial · malar · mandibular
- **치료** 국소 미백(**Kligman formula**: hydroquinone 5% + tretinoin 0.1% + dexamethasone 0.1%; kojic acid, glycolic acid, arbutin, α -bisabolol) · 경구 tranexamic acid · chemical peel(TCA, glycolic, oxygen peel) · 광(low-fluence 1064nm QSNY, dye laser, 830/850nm LED, IPL)



Melanocyte

C. 구진비늘(구진인설성) 질환

강의록 목차: 건선, 장미색잔비늘증, 모공성홍색잔비늘증, 박탈피부염, 유건선, 흰색잔비늘증, 편평태선, 광택태선, 선상태선 (슬라이드는 건선~편평태선만 수록)

1. 건선 (Psoriasis)

- 정의 은백색 인설을 동반한 구진·판의 흔한 만성 재발성 염증성 질환. 호발: 두피, 팔꿈치, 무릎, 사지 신측, 천골부, 손발톱, 배꼽
- 역학 유병률 미국 2% / 한국 약 1% · 초발 10~30대 (20대>10대>30대; 조기초발형/만기초발형) · 가족력 백인 1/3, 한국 약 25%
- 악화요인 피부외상(Koebner), 감염(β -streptococcus $\rightarrow$ 물방울양 건선), 기후(겨울, 고위도), 건조한 피부, 스트레스, 약물(lithium, β -blocker, chloroquine, NSAID[indomethacin])
- 병인 유전요인 + 면역병인(initiation $\rightarrow$ amplification[급성] $\rightarrow$ maintenance[만성]). pDC·myeloid DC·T cell·keratinocyte·neutrophil, cytokine·chemokine
- 임상형 vulgaris(plaque) · guttate(eruptive) · inverse(flexural) · pustular(generalized/localized) · erythroderma
- Koebner 현상(isomorphic response, 사소한 외상 부위에 병변; LP·lichen nitidus·PRP에서도) · Auspitz sign(인설 제거 시 점상출혈) · 지도설 · 손발톱 pitting(30-50%)
- 건선성 관절염(PsA): 건선의 6-42%, 일반인구 0.05-1%, 발병 peak 35-40세, 성별차 없음 (건선 유병률 0.5-3%)
- 치료 외용 1차: emollient, glucocorticoid, vitamin D3 analog / 2차: dithranol, tazarotene, tar · 광치료 PUVA, NBUVB · 전신 MTX, cyclosporine, retinoid, biologics

기출 선지 ① 일반 '25 '23 '22 '21

○ 자극·외상으로 악화될 수 있다 (악화인자: 추위·외상·약물·기후·연쇄상구균 감염)

✗ 초발연령 40~50대 이상, 남자에서 흔함 · 가족력 75% · 스트레스는 악화요인이 아님 · 유병률 10%

② PsA '25 '23 '22 '21

○ 30~40대 호발 / 성별 차이 없음

✗ 20대 호발 · 남성 호발 · 건선환자의 약 70% 동반 · 전체 인구 유병률 약 5% · 손톱건선과 거의 동반되지 않음

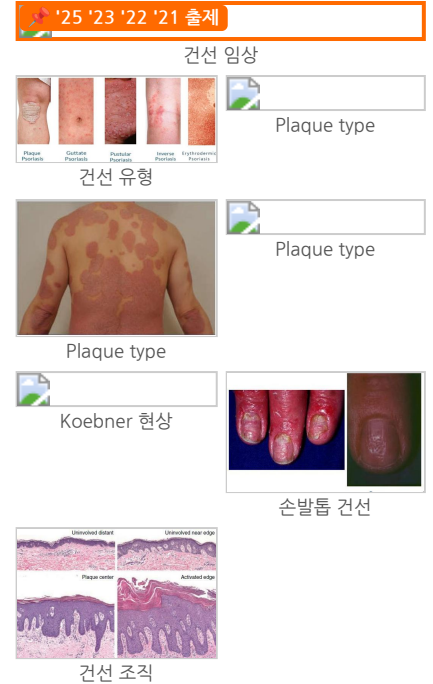
③ 치료 '25 '23 '22 '21

○ 광선치료는 주로 NBUVB가 이용된다

✗ 1차 외용제로 retinoid ($\rightarrow$ vit D3가 1차 외용제) · 2차 외용제로 vit D3 · MTX/cyclosporin/retinoid가 부작용 적어 편하게 사용 · 순환치료는 필요 없다

'19 : ○ 병변 정도(mild/moderate/severe)에 따라 다르게 치료 · ✗ Biologics 사용 금지 · mild는 1차로 경구제 · MTX/cyclosporin 검사 없이 장기 투여 · 광치료는 부작용이 심해 사용 안 함

족보 추가 손톱건선은 PsA와 흔히 동반됨 · 건선 치료는 한 가지만 쓰지 않고 순환치료(rotational)를 시행.



2. 장미색잔비늘증 (Pityriasis rosea)

- 원인 불명의 가벼운 염증성 발진. 연어색 구진·반 + collarette 인설
- 대개 단일 herald patch(mother patch)로 시작 $\rightarrow$ 1-2주 후 급속 파종 $\rightarrow$ 3-8주에 자연 소실. 병변 장축이 피부 할선(lines of cleavage)과 평행

기출 선지 '19 진단에 유용한 sign

○ Herald patch

✗ Koebner · Auspitz sign · Wickham's striae · Pterygium formation

족보 추가 상기도·후두염 등 선행 감염 후 면역반응으로 약 2주 뒤 발생(족보 해설).



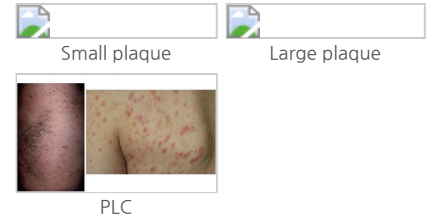
3. 모공성홍색잔비늘증 (Pityriasis rubra pilaris)

- 만성. 작은 모공성 구진, 노르스름한 분홍 인설반, 융합된 손발바닥 각화증
- 중심 각질마개(horny plug)가 있는 갈색 핀머리 크기 구진 · 두피 인설·홍반으로 시작 · 정상 피부 섬(small islands of normal skin) · 손발바닥 각화증 + 균열(발 측면 'sandal' 모양) · 손발톱 둔하고 두껍고 잘 부서짐(pit 거의 없음)



4. 유건선 · 태선모양잔비늘증

- **Parapsoriasis**: 만성, 치료 저항, 자각증상 없는 반구진 인설성 발진군
· Small plaque(1-5cm): 림프종으로 진행 X · Large plaque(5-15cm): **10-30%에서 T-cell lymphoma**(특히 심한 소양증)
- **Pityriasis lichenoides**: PLEVA(Mucha-Haberman; 급성·self-limiting, 반·구진·수포의 다형성 발진) / PLC(만성; 홍반·황색 인설성 반과 태선양 구진, 서서히 발생, 수개월~수년 후 자연 소실)



5. 편평태선 (Lichen planus)

- 소양성 염증성 질환(피부·모낭·점막). **Pathognomonic**: 작고 보라색(violaceous) 편평 다각형 구진
- **Wickham's striae**: 병변을 가로지르는 회백색 점·선 · 호발: 굴측 손목, 체간, 내측 대퇴, 정강이, 손등, 귀두 · Koebner 현상(+)
- **손발톱**: pterygium formation이 특징, 중주 홈, 원위·근위 조갑박리, ridging, splitting, midline fissure
- **구강**: reticular(볼 안쪽) / atrophic / ulcerative(erosive) = 전암 상태 · 생식기: 귀두 편평 다각형 구진·환상 배열 / 음순·항문은 침연으로 희게 보임



기출 선지 '19 회백색 띠(특징적 양상)

○ Wickham striae

✗ Auspitz sign · Christmas tree pattern · Geographic tongue · Herald patch

2025 실제 시험지(한형진 파트) 정리

번호	주제	정답	근거
73	건선 임상 (사진 문제)	③ 자극·외상으로 악화	족보 확인
74	건선성 관절염	② 성별 유병률 차이 없음	족보 확인
75	건선 치료	③ NBUVB	'23 동일 문항(족보)
76	UV 작용	① UVA melanogenic	족보 확인
77	UV 유해 작용	② 홍반·tanning = 급성*	강의록 기준 풀이(공식 정답 미확인)
78	진피 melanocytosis	③ Mongolian spot	족보 확인
79	백반증 (사진 문제)	③ segmental / non-segmental / focal	'22 동일 계열 · 강의록 기준
80	전구암증 아닌 것	⑤ IP	족보 확인
81	SCC 고위험 인자	② 3cm 크기	강의록 기준 풀이(공식 정답 미확인)

※ 이 정리본에 없는 피부 강의(김현지: 알레르기·감염성 피부질환 / 방동식: 피부 구조·전신질환 피부양상)는 제공된 강의록에 없어 제외했습니다. 77번·81번은 족보에 정답이 없어 강의록 근거로 추정한 값이므로 공식 정답을 확인하세요.